

1	Nome: Luis Carlos De Sousa Nascimento Idade: 16 anos RGHC: 6141418J Peso: 29 kg Peso calórico: 16,9 kcal # DIH: 07/02/2026 # Prévio: > Mucopolissacaridose tipo IIIA > Hipertrofia ventricular esquerda (ECO mai/24) Escoliose Disfagia - GTT em agosto de 2022 > Hepatoesplenomegalia > Plaquetopenia (provável hiperesplenismo) 3 internações prévias com necessidade IOT (última em fev/2025) # Atual: PAC Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	Índice de Gravidade () Estável (x) Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: (x) Resp () Circ () Neuro	HPMA: 04/02: início de tosse e coriza. 06/02: passou a apresentar febre (38°C) 07/02: De madrugada evoluiu com desconforto respiratório o que motivou a busca por atendimento. Mãe nega alterações urinárias e de hábito intestinal. Nega vômitos, mantém a aceitação de dieta pela GTT. Durante atendimento apresentou nova dessaturação mesmo em CN 1,5L/min, optado por escalar suporte para MNR, tolerando desmame até MV 40%. Realizado RX tórax com consolidação bibasal (pior a direita), realizado 1 ciclo de salbutamol e optado pela coleta de exames laboratoriais, início de antibioticoterapia (ceftriaxone 50 mg/kg) e solicitado atendimento de equipe de fisioterapia (RPPI). > A noite nova piora do padrão respiratório, muito secretivo, com melhora parcial após. Optado por aumentar ceftriaxona para 100mg/kg/dia	# LABS: 07/02: Hb 9,9 / Ht 30,9 / leuco 4740 (S 80% / L 17%) / plaq 69 mil / gaso pH 7,45 ; pCO2 36 ; gli 119 ; Cl 111 ; Na 142 ; K 3,9 ; lact 9 ; Cal 4,74 PCR 357 # IMAGEM: (07/02): RX tórax com consolidação bibasal (pior a direita) e velamento do seio costofrênico a esquerda # INFECCIOSO: HMCp (07/02): PN (08/02)	# PRESCRIÇÃO: Dieta polimérica 250ml 4 Ceftriaxone 100mg/kg/c 12/12h (Di 08/02) Oseltamivir 75 mg VG 12 Dipirona 600mg EV SN Ondansetrona 6 mg EV S #MUC: Periciazina 4% 20 gotas (1mg/ gota) Baclofeno 10mg (1/2cp 1/2cp) Atropina 2 gotas (2x ao c Propantelina aplicar 2 ve dia Ad-til 5 gotas 1 x ao dia Salmeterol+futicasona (25+125mcg) 2 puffs 12/ PEG 14g 1x/dia Clorpromazina 2 gts 8/8 # Alergia: Nega # Recebeu: Ceftriaxona 5 mg/kg (07/02 10:40) # SV: MV 40% # SCATS: AVP em MSD GTT
2	Nome: Emanuella Vitória dos Santos Idade: 7a RGHC: Peso: 40 kg Peso calórico: 19 kcal # DIH: 06/02/2026 # Prévio: > Hidrocefalia DVP aos 3 meses, sem trocas > Mielomeningocele corrigida intraútero com 25 sem > Medula ancorada correção dez/2023 >> Em 20/12/23 ficou internada para realização de cirurgia em medula pois estava perdendo a continência urinária e fecal. Mesmo após a cirurgia, se mantém incontinente. Bexiga Neurogênica com sondagem alívio 5x/dia >>ITU de repetição # Atual: > ITU (E. coli MS) > Constipação Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ (X) Neuro	HPMA: 04/02: febre há 4 dias associada a saída de pouca quantidade de urina durante a sondagem de alívio e com coloração alaranjada e vômitos. Coletado U1 e UCR e liberada com prescrição de ciprofloxacino 500mg 12/12h. 06/02: Convocada hoje devido a persistência de vômito, hiporexia, cefaleia, sonolência excessiva e dificuldade na deambulação por astenia. No mais, houve redução do neurológico, com sono intenso ao longo do dia. Na admissão, a paciente permanece sonolenta e apresentou 1 episódio de febre (37,7 °C), sendo medicada e iniciado antibióticoterapia com cobertura para SNC (ceftriaxona e vancomicina). Interna para avaliação da neurocirurgia e seguimento da investigação neurológica e infecciosa. 07/02: Suspensa Vancomicina (sem achados sugestivos de complicação da DVP)em conjunto com avaliação equipe de NC. 08/02: melhora da diurese e aceitação alimentar, reduzimos SMB pela metade, avaliar diurese ao fim do dia	# LABS: 08/02: PCR 45,50 Hb 11,4 Ht 33,7% Leuco 7080 (52% seg 38% linfo) PlaQ 215K 06/02: Hb 11,3 Ht 34% Leuco 9550 (N 84% BAST 2% L 8% M 6%) PLAQ 175 MIL/PCR 176,1 /GV pH 7,38 PCO2 32 BIC 18,9 GLIC 97 LACT 13 CAI 4,87/CR 0,46 U 22,4 / U1 pH 1025 NITRITO NEGATIVO PROTEÍNA + CORPOS CETÔNICO + LEUCO 1000 HEMÁC 3000 BACT AUSENTES GLIC NEGATIVO	# PRESCRIÇÃO: SMB OH 50 Ceftriaxone 2g/dia PEG 1,2g /Kg Controle diurese Sintomáticos MUC #MUC: Oxibutinina 5 mg 8/8h PEG (uso variável) # Alergia: Nega # Recebeu: # SV: AA # SCATS: AVP
3	Nome: Ester Emanuely Dias Vasconcelos Idade: 8 anos RGHC: 6162389H Peso: 24kg	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta	HPMA: 03/02: início de dispneia, cansaço e tosse seca há 8 horas . Febril de 37.5, sem outros sintomas. No ITACI, recebeu cefepima, com melhora dos	# LABS: 08/02: Hb 11,0 / Ht 33,1% ; leuco 4380 (S 58% / L 18% / M 11% / E 12%)/ PlaQ 276 mil / PCR 55,9	# PRESCRIÇÃO: Cefepime 150mg/kg/dia 8/8h (Di 03/02) Teicoplanina 10mg/kg/d 12/12h (Di 03/02)

	Peso calórico: 15,8 kcal # DIH: 03/02 # Prévio: Sepses focos pulmonares (phoenix 2) LLA B recaída precoce isolada em MO (26/05/25: 92,5% blastos) Pneumonia fúngica a D em 2025 (voriconazol) # Atual: Pneumonia à direita com derrame pleural laminar Adenovirus+ HMCc cocobacilos gram negativos (22h 01m 53s) Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	() Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp (x) um Circ () Neuro	sintomas, aventada HD de pneumonia, coletado exames laboratoriais e cancelada QT À admissão: febre + desidratação > dipirona + SF 0,9% 20mL/kg > REAVAL: mantém taquicardia e TEC flush duvidoso, mas em BEG > ECO funcional + SF 0,9% 10 mL/Kg + incluiu phoenix 04/02: Manteve taquipneia > realizado novo POCUS pulmonar (igual ao anterior). Cocos gram + em HMC PICC (22H). 05/02: paciente mantém-se taquicárdica (110) e taquipneia, porém estável hemodinamicamente. Afebril nas últimas 24h 06/02: hemodinamicamente estável, FC em melhora, sem febre há 48h. Coletado IGG (< 320), prescrita IgG 400 mg/kg conforme orientado por onco.	06/02 GV pH 7,33 pCO2 43 HOC3 22,7 Lact 14 Cal 5 Cr 0,11 Ur 16,9 Na 137 K 3,9 Mg 2,2 Hb 10,1 Ht 30% Leuco 4,08k (N53,7% L19,6% M14,2% E 11,8% B0,7%) Plaq 268k Ca 9 PCR 128,3 Cl 104,7 P 5,3 IgG < 320 04/02: Hb 10,4 / Ht 32 / Leuco 9.400 (neut 83%, bast 4%, linf 6%) / Plaq 343.000 / VCM 92 / PCR 291,6 / Na 131132 / K 3,53,9 / pH 7,29 / HCO3 15,4 / BE -11,2 / Cr 0,07 / U 7,7 / Lact 7 / Ca i 5,16 / Ca t 9,5 / P 3,9 / Mg 1,92 03/02: Cr 0,07/ Ur 14,9/ PCR 241,5**/ TGO 11,5/ TGP 12,1/ Na 135/ K 3,5/ Cal 4,7/ Hb 10,8/ Ht 32,4/ Leuco 1210/ NS 72,7/ L 11,2/ M 14,2/ E 1,2/ B 0,4/ Plt 332mil/ Mg 1,93/ P 4,6/ CaT 9,3 / INR 1,36 / Fibrin 618 # IMAGEM: RX TÓRAX (03/02): opacidade em base direita, com presença de possível derrame parapneumônico POCUS (03/02): algumas linhas Bs em base esquerda; consolidação importante em base posterior direita (sinal da maçã mordida), com presença de derrame pequeno em base posterior direita, não punçionável. Cardíaco funcional: função biventricular preservada, sem derrame, cava boa POCUS (05/02): consolidação em base de HTX direito, com derrame laminar mínimo ECOTT (05/02): sem alterações # INFECCIOSO: HMC (08/02): aguarda HMC central (03/02) aeróbio PN // anaeróbio: CocoBacilos Gram negativos em identificação (22h) 04/02: P22 adenovirus	Bactrim Voriconazol #MUC: Amoxicilina 30 mg/Kg/d Bactrim 33 mg/Kg/dia seg-quar-sex Voriconazol 16 mg/kg/d Amlodipino 5 mg 1xd Metotrexate 7 comprimidos 1x/semana (quinta-feira) Mercaptopurina 1 comprimido ao dia seg-quin / 2 comprimidos ao dia sex-dom # Alergia: nega # Recebeu: IgG 400 mg/kg SF 30 mL/Kg EV 1X (20+ após) Oseltamivir (03/02-04/02) # SV: AA # SCATS: PICC 28/01 (sem sinais flogísticos)
	Nome: João Pedro Rodrigues Passos Idade: 3 anos RGHC: 91993038H Peso: 11kg Peso calórico: 10,5 kcal # DIH: 04/02/26 # Prévio: Malformação complexa OEIS - PO 30/07/25: Correção de extrofia de cloaca, confecção de ileostomia e mitrofanoff. Rim D dilatação ureteropielocalicial + Rim E pélvico Acidose metabólica HAS	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	HPMA: 04/02: dor abdominal e recusa alimentar há 1 dia + 1 episódio de vômito + ausência de evacuações. RX de abdome com sinal de empilhamento de moedas, sugestivo de oclusão/suboclusão intestinal. Discutido com CI: optado por internação + jejum + SNG 05/02: apresentou fezes em ileostomia; aumentado Bic para 4 mEq/kg devido a bic de 16 na gaso; troca SNG para calibre maior, mantida SNG aberta. Repetiu RX abdome: CI achou que teve melhora, orientou tracionar 3cm da SNG, manteve demais condutas. 06/02: Melhora do aspecto do débito da SNG. febre 37,5°C. Iniciou quadro de diarreia, evoluiu com desidratação. Pela noite, aumentada OH para 150. Introduzido ATB de acordo com CI pelo risco de translocação. 07/02: Aumento de soro ao meio OH60/diminuiu BicNa 4meq/kg/dia . CI fechou a	# LABS: 08/02: Creat 0,07 / U 4,9 / Na 135 / K 4,5 / P 4,4 / Mg 2,07 / CaT 8,9 / Cl 100,3 / Gaso pH 7,42 ; pCO2 39 ; HCO3 25,3 ; BE 0,8 ; lact 10 ; gli 87 ; Cai 4,9 07/02: Cl 99 P 4,1 MG 2,35 NA 136 K 3,9 CAT9,3 PCR 58 HB 12,2 HT 36 LEUCOS 2560 (LINF 54% NEUT 14%) PLAQ 275K// GSV PH 7,47 PCO2 39 PO2 53 HCO3 28 BE 4,7 SPO2 85 LCT 10 CAI 4,6 06/02: GV pH 7,47 pCO2 28 HCO3 20,4 Lact 12 Cal 4,65 P 3,7 Hb 12,2 Ht 37,8% Leuco 2,39k (N48,5% L31,4% M17,6% E 2,1% E0,4%) Plaq 271k	# PRESCRIÇÃO: Dieta líquida + SNG fechada SM OH 100 Na Iso Bic 4mEq/kg/dia K 25 Soro ao meio (OH 50) Ceftriaxone 50 mg/kg/dia (07/02) Metronidazol 40mg/kg/dia (07/02) MUCs (anti hipertensivo) #MUC: Bicarbonato de sódio 10 3x ao dia (36 mEq/dia) NaCl 20% 7 mL 3x ao dia (6,5mEq/kcal) CaCO3 500 mg 1 CP 1x/c Cefalexina 5 ml 12/12h Anlodipino 3 mg/dia (Dil em 5 ml de água e toma

	# Atual: DDA Abdome agudo obstrutivo – Suboclusão intestinal Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO		SNG (12H) , avaliar quadro clinico para reiniciar dieta. 08/02: Liberada dieta liquida	Ca 9,5 Mg 2,2 PCR 62,5 Cl 107,2 Na 138 K 4,3 Ur 14,8 Cr 0,09 05/02: gasoV pH 7,38 pCO2 27 Bic 16 lactato 10 glicose 92 Cai 4,93 / Cl 106 CaT 9,7 P 4,6 Mg 2,16 Na 136 K 4,7 Cr 0,07 Ur 16,8 04/02: Hb 13,2 / Ht 38,7 / leuco 8910 (73% S / 18% L), plaq 221 mil/ (04/02): Cr 0,08/ Ur 23,4/ PCR 11,9/ Na 135/ K 4,2/ CaT 9,6/ Mg 2,35/ P 4,8/ Cl 103,2/ # IMAGEM: RX abdome: distensão de alças + nível hidroaéreo # INFECCIOSO:	Loperamida 6mg 2x ao d # Alergia: nega # Recebeu: — # SV: aa # SCATS: AVP
4	Nome: Larissa Manuela Castro dos Santos Idade: 9a9m RGHC: 92109727A Peso: 30kg Peso calórico: 17kcal # DIH: 05/02 # Prévio: Tx hepático (out/2023) por hepatite fulminante (provável hepatite autoimune) Re-Tx 08/25 (Rejeição crônica em set/24 recidiva hepatite autoimune) HDA em 11/2024 (úlcera bulbar) Colangites de repetição: out/25, dez/25, jan/26 -Dez/25: colangiografia e colocação de dreno TPH # Atual: Colangite - Clínica + piora laboratorial Síndrome gripal - Rino/entero+ Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	HPMA: 20/01-04/02: tratamento de colangite (ICr + IPER) com mero+teico (TGO/TGP, GGT, BT pioraram) 05/02: febre de 39oC + dor abdominal + cefaleia + tosse e coriza. Interna para ATB parenteral, solicitado USG de abdome. 06/02-07/02: segue afebril, bom estado geral, dor abdominal somente à palpação. 08/02: Manter ATB por pelo menos 7 dias (previsão de término em 12/02) - orientado pela CIPE	# LABS: 08/02: Hb 9,9 / Ht 31,2 / leuco 9260 (S 80,2% / L 12,6%) / plaq 268 mil / gaso pH 7,37 ; pCO2 38 ; HCO3 22 ; BE -3,3 ; lact 14 ; gli 83 ; Cai 7,99 / INR 1,0 / fib 576 / PCR 23,9 / prot totais 6,5 / alb 3,7 / Creat 0,3 / U 24,7 / Na 139 / K 4,8 / P 3,7 / Mg 2,03/ CaT 9,0 / Cl 103,5 / BT 1,03 / BD 0,8/ BI 0,23 / TGO 59,1 / TGP 99,1 / FA 236 / GGT 143 05/02: Hb 10,9 / Ht 31,9% / Leuco 15.150 (4% bastão / 82% segm / 11% linf / 3% mono) / PlaQ 297mil / CaT 9,1 / amilase 88 / BT 2,15 (BD 1,49 / BI 0,66) / FA 272 / GGT 197 / TGO 67 / TGP 100,8 / Cr 0,41 / uR 31,8 / Proteína 7,5 / Albumina 4,1 / PCR 26,8 / INR 1,02 / rTTPA 1,08 / Fibrinogênio 490 / GasoV: pH 7,47;pCO2 36; BIC 26,2; lactato 10; glicose 81; Cai 4,68 / Na 132 / K 4,5 # IMAGEM: USG abdome (05/02): fígado transplantado com ecotextura discretamente heterogêna. Dreno biliar transparietohepático. Ausência de coleções na cavidade abdomiinal. Não foram caracterizados abscessos intra-hepáticos. # INFECCIOSO: -05/02: HMCp: p neg -05/02: P22: Rino / Entero -05/02: NS1/sorologia dengue negativos	# PRESCRIÇÃO: Meropenem 60mg/kg/d 05/02 Teicoplanina 10mg/kg/d 12/12h (Di 05/02) MUC Sintomáticos #MUC: - Aciclovir 200mg 4x/dia - CaMg 500mg 2x/dia - Sol. fosfatada 5mL 2x/c - Micofenolato 250mg 2x/d - Tacrolimo 3mg 10h e 2 - AAS 100mg 1x/dia - Ursacol 150mg 2x/dia - Pantoprazol 20mg 1x/d - Prednisona 15mg 1x/di - Anlodipino 7,5mg 1x/d - Bactrin 800mg (2a,4a e # Alergia: Nega # Recebeu: # SV: AA # SCATS: DTPH (12/25), DSF?
5	Nome: Beatriz Cristina Gomes de Lima Idade: 14 anos RGHC: 92285460F Peso: 50 kg Peso calórico: 21 kcal # DIH: 06/02/26 # Prévio:	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável,	HPMA: Dez/25: Início de HD devido a piora progressiva de função renal 03/02: Última HD 05/02: faltou em entrevista em clínica externa e em tto no ICr 06/02: Encaminhado pelo do ambulatório de nefrologia para descartar emergência dialítica e programação de diálise em regime de internação.	# LABS: 06/02: Mg 2,33/ P 5,8/ CaT/ Cl 103,4/ Cr 4,38/ Ur 96,6/ Na 140/ K 4,7/ Hb 10,5/ Ht 32,4/ Leuco 6250/ NS 64,5/ L 25,6/ M 8/ E 1,6/ B 0,3/ Plt 247mil/ GasoV: pH 7,42/ PCO2 38/ PO2 48/ HCO3 24,6/ BE 0,1/ Lactato 10/ Glicose 98/ Cal 4,39	# PRESCRIÇÃO: MUC #MUC: Prednisona 10 mg 1x/dia MMF 500 mg 12/12h Atenolol 25mg 1x ao dia Carbonato de cálcio 2 g BicNa 1 g 8/8h

	GESF colapsante Sd Nefrótica (primo descompensação em 2024) Início hemodiálise em 2025 # Atual: Má adesão ao tratamento com necessidade de HD Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	07/02: Diálise à tarde sem intercorrências.	# IMAGEM: # INFECCIOSO:	EPO 2400 UI SC terça e s na HD Calcitriol 0,25 mcg (seg, sex) Vit D 25 mil UI 1x/seman Sevelamer 800mg 8/8h # Alergia: Nega # Recebeu: # SV: AA # SCATS:
	Nome: Victor Hugo da Cruz Siqueira Idade: 13 anos RGHC: 92757168E Peso: 72 kg Peso calórico: 25,4 kcal # DIH: 07/02 # Prévio: - Asma (sic) # Atual: - Síndrome nefrótica a/e Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	HPMA: Paciente iniciou quadro de fadiga e edema em região periorbitário e de membros inferiores há 2 semanas. Refere episódio isolado de cefaleia e vômito dois dias antes de iniciar o quadro. Fez exames externos com alteração de proteína na urina além de PAS 150x90 medida em serviço externo. Paciente nega dispnéia ao repouso, refere somente aos grandes esforços. Refere ganho de peso de 3kg de ontem para hoje, urina espumosa, nega hematúria. Nefrologia orienta início de corticóide e suspensão de diuréticos prescritos em serviço externo. Realizado POCUS sem derrames cavitários. 08/02: sem critérios pra albumina	# LABS: (08/02) Hb 12,9 / Ht 35,8 / leuco 10700 (S 87,7% / L 10,3%) / plaq 499 mil / gaso pH 7,39 / pCO2 44 ; HCO3 26,6 ; BE 1,6 ; lact 15 ; gli 120 ; Cai 4,65 / PCR 0,1 / prot totais 4,0 / alb 2,1 / Creat 0,71 / U 35,8 / Na 133 / K 4,3 / P 6,2 / Mg 2,21 / CaT 8,3 / Cl 99,5 (07/02): Hb 12,5 Ht 35 Leuco 12.990 (Seg 64,6 L 29 M 5,2 E 0,6 B 0,6) PlaQ 527.000 U 42,7 Creat 0,76 Na 131 K 3,7 Mg 2,33 P 5,5 Cl 98,7 CT 314 HDL 98 LDL 185 TG 137 Prot totais 4,1 Alb 2,4 GasoV pH 7,38 pO2 28 pCO2 56 HCO3 33,1 Lact 13 Cal 4,67 Urina I: pH 6,0 Densidade 1015 Proteínas 4+ P/C 9 # IMAGEM: USG rins e vias urinárias (29/01) - externo: nefropatia aguda parenquimatosa bilateral # INFECCIOSO:	# PRESCRIÇÃO: Dieta hipossódica Prednisona 60 mg VO 1x Albendazol 400mg VO 1x (5 dias) Sintomáticos #MUC: - # Alergia: Nega # Recebeu: - # SV: AA # SCATS: AVP
	Nome: Benjamin Vieira Vitorino Idade: 3 anos RGHC: 91991825C Peso: 18kg Peso calórico: 14kcal # DIH: 07/02 # Prévio: 1)Hidrocefalia pós-abscesso cerebral (encefalite por Proteus mirabilis em maio-junho/2022) >Em uso de DVP (última troca/revisão em outubro/2024) 2)Erro inato da imunidade em investigação pela imunologia # Atual: Escapes convulsivos a/e - Piora de hidrocefalia? Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	HPMA: 07/02: Paciente é trazido ao SCUT pela mãe por quadro de episódio convulsivo de 4 minutos associado a cianose perioral, saída de espuma pela boca, seguido por rebaixamento de nível de consciência por ~2 minutos após. Mãe relata respiração fraca após convulsão e lento retorno ao estado basal. Nega alteração de trato genitourinário e gastrointestinal. Nega febre, mas refere dois episódios de vômitos após crise. Realizado RX de trajeto e TC de crânio para avaliar funcionamento de DVP e solicitada avaliação da equipe de neurocirurgia que que indicou observação de padrão neurológico internado devido ligeira dilatação de ventrículo em TC de crânio e solicitação de avaliação pela neuroclínica. 08/02: Introduzimos levetiracetam 15 mg/kg/d	# LABS: # IMAGEM: TC de crânio (laudo verbal): ligeira dilatação de ventrículo em relação a imagem anterior RX de trajeto: sem fratura aparente de DVP # INFECCIOSO:	# PRESCRIÇÃO: Levetiracetam 150 mg V 12/12h (15 mg/kg/d) #MUC: Nega # Alergia: Nega # Recebeu: # SV: AA # SCATS:

6	Nome: Ayanna Regina de Santana Idade: 1a RGHC: 92395096E Peso: 7,5kg Peso calórico: 7,5kcal # DIH: 07/02 # Prévio: - Síndrome CANDLE-like - Síndrome autoinflamatória associada ao proteassoma > Fenótipo: Imunodeficiência primária com hipogamaglobulinemia IgG e IgM - Hepatite crônica (canaliculares e transaminases) - HAS de difícil controle - DRC IV (ClCr set/2025: 85) # Atual: Sd. Gripal? Pneumonia? Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	HPMA: 05/02: buscou atendimento no SCUT por hiperemia do portcath, liberada após avaliação exames com ciprofloxacino, 05/02-07/02: paciente começou a apresentar febre em 05/02, com pico máximo de até 38,2º (em 07/02). Apresentou 2 episódios de vômitos, com piora do desconforto respiratório e necessidade de O2 domiciliar 1L/min por dessaturação até 75% aa. Nega alterações em diurese e evacuações. Nega espirros, coriza ou demais sintomas. Nega alterações de pele ou em GTT. Em 21/05 fez troca de Portocath por equipe de Cirurgia Infantil.	# LABS: 08/02: Hb 10,6 / Ht 33,2% / Leuco 6950 (8% bastão / 60% segm / 22% linf / 10% mono) / Plaq 115mil / Gasov: pH 7,32; pCO2 48; BIC 24,7; Na 131; K 4,6; Cl 103; glicose 81; lactato 35; Cai 5,15 / PCR 9,2 / Cr 0,26 / Ur 22 / Na 136 / K 4,9 / P 6,1 / Mg 2,42 / CaT 9,4 / Cl 100,5 # IMAGEM: RX de tórax (07/02): opacidade ápice HTX direito? # INFECCIOSO: Ag HMC	# PRESCRIÇÃO: Levofloxacino 10mg/kg/ Oseltamivir 30mg 12/12 MUCs #MUC: Sulfametoxazol + trimetoprim 750 mg/m²/dia de 12/12 (100mg 12/12hs) às segundas, quartas e sextas (profilático) 2,0mL Prednisolona 5,4mg 12/12 Omeprazol 0,6mg/kg/dia Levetiracetam 80mg 12/12 Furosemida 2,5mg 12/12 Hidralazina 8mg 6/6h Anlodipino 4mg 1x/dia Metoprolol 3,75mg 12/12 BicNa 400mg 12/12h (200mg 12/12h) 200 meq/kg/dia Salmeterol + fluticasona 125mcg 12/12h 2 puffs 12/12 Enalapril 1,5mg 1x/dia Fluconazol 30mg 1x/dia Gabapentina 0,5ml 12/12 # Alergia: Nega # Recebeu: # SV: CN O2 # SCATS: Portocath
7	Nome: Miguel Batista dos Santos Idade: 5a8m RGHC: 91753266I Peso: 15kg Peso calórico: 12,5kcal # DIH: 07/02/26 # Prévio: - DRC classe V por duplicidade pielocalinicial e rins displásicos bilateralmente (HD 6x/semana; anúrico) - HAS, hipertrofia concêntrica de VE - Falência de acesso vascular - ICS: Pseudomonas aeruginosa e Morganella morganii (05/01/26), Staphylo aureus OxaS (09/25) e Proteus mirabilis (11/25) - Trombo em VJIE (USG cervical 11/25) - Infecção de Óstio de Permcath em Azigo (04/25) - Crise convulsiva tônico-clônica (04/25) - Anafilaxia PFC (11/24) - AVCi/stroke mimics (hemiparesia à esquerda e NOIA) (03/23) - Estenose subglótica (TQT 03/22) - PCR (08/20 e 02/22) - PO piloromiotomia + gastrostomia (07/20) # Atual: Febre de foco a/e -- Infecção de corrente sanguínea?	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	HPMA: Internação recente por ICS relacionada a cateter por Pseudomonas aeruginosa e Morganella morganii (mantidos acessos em azigos e femoral devido falha de acesso vascular) 07/02: HD sem intercorrências pela manhã; febre (39,4°C), aumento de secreção em traqueostomia, dessaturação e vômitos à tarde. Buscou SCUT: à admissão, taquicardia (FC 202bpm) e febre elevada (T 39,8°C), além de extremidades frias e pulsos periféricos finos, sendo levado à SE. Realizada dose de dipirona e ondansetrona enteral,além de paracetamol por persistência da febre e introduzido ATB (meropenem e amicacina - último esquema antimicrobiano utilizado), coletado NS1.	# LABS: 08/02 Cl 96,6 / Ca 10,1 / Mg 2,15 / Na 137 / K 5,1 / PCR 29,8 / gasov pH 7,41 pCO2 33 HCO3 27,9 lactato 13 glicose 84 Ca io 5,02 / Hb 9,1 Ht 28,8 leuco 10150 (bat metamielo 1% bast 13% S 74% L 8% M 4%) plaq 320mil / TP 15,6 INR 1,18 TT 16,6 TTPA 46,7 R 1,39 07/02: Cl 101,8 / P 2,8 / Mg 2,52 / Ca 10,6 / Na 135 / K 5,7 / gasov pH 7,35 pCO2 44 HCO3 24,3 lactato 6 glicose 86 Ca io 5,54 # IMAGEM: # INFECCIOSO: 08/02: HMCc Permcath ázigos PN* HMCc Permcath VFD PN* HMCp PN* 08/02: Flucorv aguarda*	# PRESCRIÇÃO: Fórmula infantil hipercalórica 100ml 3/3h com módulo proteína 2% Meropenem 560mg EV 12/12 (80mg/kg/dia - ajustada função renal) - Di 08/02 Amicacina 75mg EV 1x/dia (5mg/kg/dia) - Di 08/02 #MUC: Levetiracetam 130mg VO 12/12h Omeprazol 15mg VG 1x/dia Bicarbonato de sódio 1g 8/8h Poliestirenosulfonato de sódio 10g VG 2x/dia (aos domingos dia sem diálise) Enoxaparina 10mg SC 1x/dia (sem hemodiálise) EPO 2000UI SC 3x/semana (segunda, quarta e sexta) # Alergia: Nega # Recebeu: # SV: AA # SCATS: TQT 3,0 c/ cuffs // Permcath VFD e Permcath ázigos 06/08/2025

	Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO				
8	Nome: Beatryz Almeida Cardoso dos Santos Silva Idade: 16 anos RGHC: 14328905H Peso: 78kg Peso calórico: # DIH: 08/02 # Prévio: Hidradenite supurativa PO Excisão em região axilar direita (28/01/2026) # Atual: Deiscência de ferida operatória – Infecção secundária? Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	HPMA: 06/02: abertura de alguns pontos de FO 08/02: deiscência total de ferida operatória em região axilar direita com saída de secreção purulenta, associada a dor local; sem febre	# LABS: (08/02): Hb 12,6 / Ht 38,4 / leuco 14940 (S 78,2% / L 14,3%) / plaq 558 mil / PCR 57,7 # IMAGEM: # INFECCIOSO:	# PRESCRIÇÃO: Clindamicina 600mg 8/8 Ceftriaxone 1g 12/12h #MUC: # Alergia: Nega # Recebeu: # SV: AA # SCATS:
9	Nome: Nycolle de Souza Rodrigues Idade: 16a RGHC: 92757320F Peso: 109kg Peso calórico: 32,8kcal # DIH: 08/02 # Prévio: Obesidade # Atual: Colecistite aguda/coledocolitíase? Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	HPMA: 01/02: início de dor em hipocôndrio direito e epigástrio que irradia para as costa. Apresentou 2 episódios de vômitos de conteúdo alimentar desde o início do quadro. nega colúria ou acolia. Nega febre. 01-03/02 fez uso de tramal, cetoprofeno e buscopan, quando a medicação foi substituída por lonium por suspeita de síndrome do intestino irritável. 06/02: Evoluiu com progressão da intensidade da dor e aparecimento da icterícia, quando procurou PS externo no dia 07/02, onde foi feito USG e TC abdome (vide laudo abaixo) e exames laboratoriais com elevação de transaminases, enzimas canaliculares e bilirrubina a custa de direta. 07/02: A admissão evidenciado paciente em bom estado geral, com fácies de dor, ictérica, com dor em HCD de moderada intensidade. Realizada analgesia com dipirona e cetoprofeno, coletados exames, realizado USG abdominal e solicitada avaliação da CI, que orientou manter paciente internada e iniciar ATB por suspeita de colecistite aguda/coledocolitíase, com reavaliação amanhã para programar exame de imagem com maior detalhamento. 08/02: CI orienta liberar dieta hipogordurosa, amanhã fazer imagemd e vvb e recoletar labs.	# LABS: 08/02: Hb 14,1 / Ht 45% / Leuco 11.540 (segm 64,6% / linf 24,3% / mono 9,2% / eos 1,6% / baso 0,3%) / Plaqa 255mil / PCR 17,5 / Cr 0,82 / Ur 22,2 / Na 141 / K 4,5 / P 4,2 / Mg 2,31 / CaT 9,5 / Cl 103,8 / Amilase 36 / GGT 264 / FA 191 / BT 3,88 / BD 3,02 / BI 0,86 / TGO 215,8 / TGP 338,4 / Gasov: pH 7,36; pCO2 44; BIC 24,9; lactato 18; glicose 101; Cai 4,91; K 4; Na 136; Cl 104 # IMAGEM: Externo: US abd total (07/02): leve dilatação das vias biliares extra hepáticas sem caracterização de fator obstrutivo TC abdome 07/02: Mínima ectasia das vias biliares intra e extra-hepáticas com calibre de colédoco até 9mm, sem fator obstrutivo pela tomografia. Pequeno cálculo na vesícula biliar sem sinais de colecistite aguda. Pâncreas com morfologia preservada USG (08/02): Colecistopatia calculosa. Diante da suspeita clínica de coledocolitíase, a ressonância magnética de abdome superior pode trazer mais informações. # INFECCIOSO:	# PRESCRIÇÃO: Dieta hipogordurosa Cefotaxima 150mg/kg/d Di 08/02 Ampicilina 2g EV 6/6h D Dipirona 1g 6/6h Cetoprofeno 50mg 6/6h Escopolamina 40mg 8/8 Sintomáticos #MUC: Nega # Alergia: Nega # Recebeu: Escopolamina, cetoprofeno, dipirona # SV: AA # SCATS: AVP
10	Nome: Loreнна Duarte Oliveira Idade: 14a RGHC: 14028001C	Índice de Gravidade	HPMA: 02/02 - iniciou quadro de náusea, vômitos e falta de apetite. Evolui ao longo da semana com	# LABS: # IMAGEM:	# PRESCRIÇÃO: Sintomáticos SN

	Peso: 80,9kg Peso calórico: 27,2kcal # DIH: 08/02 # Prévio: - Ganglioma cerebelar e de tronco encefálico grau I parcialmente ressecado com colocação de DVP em 2012 > Em seguimento com a Oncologia ICR, última consulta há 1 semana > Mau funcionamento de DVP em junho/24 (cefaleia + sonolência + aumento de hidrocefalia) > PO (13/06/2024) Revisão de DVP de média pressão com troca de válvula de média pressão HPBIO e cateter distal - Anacusia à direita # Atual: Alteração neurológica aguda (marcha + desvio do olhar E) > Progressão de doença? Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	(x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	cefaléia, sonolência, diminuição da frequência urinária e urina mais concentrada Ademais mãe percebeu desvio do olhar para a E. Nega febre, alterações de hábito intestinal. Relata também dor inespecífica em flancos bilateralmente, sem fatores de melhora ou piora, de forma intermitente. Tem episódios de tontura associados à cefaleia, visão turva e dificuldade para deambular. 07/02: SCUT → estável hemodinamicamente. Solicitado RX de trajeto e TC de crânio, sem indicação de abordagem (alta por parte deles). Porém, paciente mantendo déficits, sendo optado por internação hospitalar	RX de trajeto: sem alterações TC de crânio: achados estáveis em comparação a imagem prévia # INFECCIOSO:	#MUC: Nega # Alergia: Nega # Recebeu: # SV: AA # SCATS:
--	---	--	---	---	---

VAI INTERNAR

MODELO - NÃO APAGAR E NÃO USAR, FAZER CÓPIA !!!!! Ok!!!!!!!!!!

Nome: Idade: RGHC: Peso: Peso calórico: # DIH: # Prévio: # Atual: Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	HPMA:	# LABS: # IMAGEM: # INFECCIOSO:	# PRESCRIÇÃO: #MUC: # Alergia: Nega # Recebeu: # SV: AA # SCATS:
--	--	--------------	--	--

TALVEZ VOLTE

1	Nome: Ester Bonfim Costa Idade: 16 anos RGHC: 6161213K Peso: 101,7 kg Peso calórico: 31,34 kcal # DIH: 30/01 # Prévio: Doença de Graves HAS TAB (tentativa prévia de suicídio) # Atual: Hipertireoidismo com doença de Graves Necessidade de Tireoidectomia	Índice de Gravidade (x) Estável () Alerta () Instável se alerta ou instável, atentar para sistema: () Resp () Circ () Neuro	HPMA: Paciente em programação de internação para realização de 7 dias de Lugol previamente à realização de tireoidectomia. Paciente em vigência de sintomas relacionados ao trato gastrointestinal, como diarreia e dor abdominal há 1 dia.	# LABS: 27/01: TSH 0,02 T4L 2,89 T3 303 T4 19,5 anti-TPO >900 anti-Tg 11 # IMAGEM: USG tireoide (23/01): bócio difuso heterogêneo # INFECCIOSO:	# PRESCRIÇÃO: Lugol 5% 5 gts 8/8h por 7 d Sintomáticos MUCs #MUC: Tapazol 30 mg 1 vez ao dia Propranolol 30 mg 8/8h - Omeprazol 40mg/dia Anlodipino 10mg 1x/dia Fluoxetina 20 mg 1x/dia Carbonato de lítio 300mg 1x/dia # Alergia: Nega # Recebeu:
---	---	---	---	--	--

	Diagnóstico compartilhado com a família? SIM Evolução noturna? SIM Aerossolização? NÃO				# SV: AA # SCATS:
--	---	--	--	--	--

DATA / AUTORIZAÇÃO	DADOS DO PACIENTE (PREENCHIDO PELOS RESIDENTES)	
03/02 (autorizado em 26/01)	Daniel Soares Magdalena	Abordagem de DVP disfuncionante por equipe c
09/02	Ravy Lopes Pereira da Silva	Biópsia de nódulo no braço (necrose gordurosa)

DATA / AUTORIZAÇÃO	GESTÃO DE LEITOS ICR (NÃO APAGAR)	
06/02/2026 Dra Luanna PS / Dr Gabriel da CTIP e Dra Bianca da CI	Vaga cedida para internar DIRETO na CTIP 06/02/2026 - Ficha CROSS N° SS-13357426-26 - RAVI LUCAS OLIVEIRA SILVA - Hosp Darcy Vargas - Insuficiência Hepática.	
06/02/2026 19h- Passado Plantão para Dra Luanna ESP1: 1 vaga disponível (berço isolamento) ** OBS: 1 leito interditado com problema no ar condicionado (leito 11) EPED: 1 vaga (berço) disponível - (Contingência disponível -cama) ESP2(SUS): –TX Renal: Leito sendo usado por paciente de convênio –Leito SUS Obra: ICARO LIMA RAMOS NEGRINI (nefro)	Resumo dos leitos de UTI ICR (16 leitos operacionais) 06/02/2026 - 19h ** 15 pacientes internados Vaga de UTI cedida hoje para: Hospital Darcy Vargas - RAVI LUCAS OLIVEIRA SILVA - Insuficiência hepática. Alta aguardando vaga na ESP2: <i>DAVI AQUINO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA</i> *Ficará sem leito de UTI disponível. **Solicitação de vaga de UTI para 09/02/2026: -Da ECI: LETICIA ALMEIDA FIGUEIREDO - programado TX Hepático	

IMPRESSOS ÚTEIS:

AIH

casos de perfil para avaliação no PS ORL-ICHC: Corpo Estranho Nariz/Ouvido, Epistaxe, Complicações Graves De Ivas

casos que podem ser avaliados em UBS/AME: Ivas Sem Complicação, Cerume Sem Clínica De Otite (evitar Enviar Casos Simples Para Serviço Terciário E Valorizar Níveis Primário E Secundário)

pacientes avaliados pela porta do SCUT sem previsão de internação (mesmo que na triagem):

- Passar Caso Para O Ps Da Orl Pelo Ramal 6581 Ou Celular Corporativo (11 94711-2561)
- Discutir Com Equipe Orl Indicação Da Avaliação E Necessidade De Paciente Retornar Ou Não Ao Scut Após Aval Orl
- Pedir Transporte Junto À Equipe De Enfermagem Scut Ou Encaminhar Por Meios Próprios Em Caso De Estabilidade
- sempre Encaminhar Acompanhado Do Papel Timbrado “Encaminhamento Interno De Pacientes” Preenchido

Formulário de LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

Contrarreferência

FLUXOS ICR → ICHC: fluxos alinhados com os preceptores das especialidades e plantão dengues em março/2023

